

Лечение опухолей глаза и орбиты

Ажигалиева М.Н.

Казахский НИИ глазных болезней

Көз және көзұясы ісіктерін емдеу

Әжигалиева М.Н.

Мақсаты – көз және көзұясы ісіктерін емдеудегі электронды терапия рөлін анықтау.

Мәліметтермен әдістер: Көз және көзұясы ісіктерімен ауырған 17 науқастарды емдеу қорытындылары анықталды.

Қорытынды. Электронды терапия жүргізілгеннен кейінгі жекеленген қорытындылардың көрсеткіші, 17 науқастың 3 жылдан кейін 12 тірі қалды, 4 өлді, бір науқастан хабар жоқ. Тексеру барысында, III және IV сатыдағы науқастар арасында өліл-жітімнің болғандығы анықталды. Біріктірілген емдеу әдісінде емнің әсер ету пайызы емдеуге дейінгі ісіктің таралуы мен аурудың сатысына байланысты болғаны байқалды. Егер ем неғұрлым ерте кезеңде жүргізілсе, емделу пайызы жоғары болды. Емдеуден бұрын ісік көз алмасының шеңберінен асып кеткен болса, емдеу пайызы аз болды. Тікелей қанағаттанарлық және жақын арадағы қорытындылар бізге әсіресе мынадай оқиғаларда, ісік көз шеңберінен асып таралып кеткен жағдайларда жылдам электрондарды қолдануға нұсқау бергізді.

Treatment Of Eye And Orbit Tumours

Goel – study the vole of electronic therapy in the treatment of eye and orbit tumours.

Material and methods: The results of treatment of 17 patients with eye and orbit tumours have been studied. The long-term results of the treatment were studied following electronic therapy conducted.

Results. The study of long-term results of conducted electronic therapy showed that after 3 years, 12 out of 17 patients survive, 4 died, there is no data on one patient.

Accordingly, the lethality was noted among patients with the III and IV stages.

Цель – изучить роль электронной терапии в лечении опухолей глаз и орбиты.

Материал и методы: Изучены результаты лечения 17 больных опухолями глаз и орбиты. Изучены отдаленные результаты лечения после проведенной электронной терапии.

Результаты. Изучение отдаленных результатов после проведенной электронной терапии показало, что из 17 больных через 3 года живы 12, умерло 4, нет сведений об одном больном. Следовательно, летальность среди больных отмечалась у больных с III и IV стадиями. При комбинированном методе лечения выявляется зависимость процента излечения от степени распространенности опухоли к моменту лечения. Если лечение проводилось в более ранние сроки, процент излечения был высоким. При лечении в период, когда опухоль вышла за пределы глазного яблока, процент излечения был меньше. Удовлетворительные непосредственные и ближайшие результаты позволяют нам рекомендовать применение быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда имеет место прорастание опухоли за пределы глаза.

Wherever a combined treatment method is applied, the correlation between the percentage of cured and the degree of tumour spread.

If the treatment was conducted at the earlier stage, the percentage of successful treatment was high. When the treatment was conducted where the tumour spread outside of the eyeball boundaries, the percentage of those cured was lower.

Satisfactory, comprehensive and nearest results allow us to recommend the application of rapid electrons, particularly in cases, where the growth of the human outside eye bounding has taken place.

Актуальность

Анализ результатов лечения внутриглазных опухолей показал, что кроме хирургического лечения необходимо дополнительно использовать электронную терапию, как в начальных, поздних стадиях заболевания.

В начальных клинических стадиях заболевания показано оперативное вмешательство. По данным литературы, при запущенных стадиях послеоперационная летальность достигает 90% и более. Поэтому многие авторы рекомендуют комбинированное лечение, при котором результаты получаются лучше, чем при хирургическом методе.

В последние годы в связи с появлением новых источников излучения открылись новые перспективы в лечении опухолей глаза и орбиты. Обычно в офтальмологической практике применяется классическая рентгенотерапия с двух полей – переднего и бокового. При таком облучении в зону максимальной дозы включается не только опухоль, но и нормальные ткани глаза: 20-25% дозы поглощаются в соседнем глазе, а 20-30% ее падают на ближайшие отделы головного мозга. В то же время такое облучение опухоли оказывается недостаточно эффективным.

Другим распространенным методом лечения является лучевая терапия. Литературные данные об этом противоречивы. До настоящего времени нерешенным остается вопрос о целесообразности применения лучевой терапии после хирургического вмешательства. При опухолях орбиты применяются радиевые аппликаторы, рентгеновское и гамма-облучение, сочетанная лучевая терапия. Однако, при всех этих методах результаты оказались неутешительными. С усовершенствованием техники лучевой терапии они несколько улучшились.

Лучевая терапия при опухолях орбиты в настоящее время получила распространение в некоторых зарубежных клиниках в связи с применением электронной терапии. При лечении опухолей орбиты она позволяет обеспечить наиболее оптимальное дозное распределение поглощенной энергии с высоким градиентом между здоровыми тканями и опухолью. Однако с клинических позиций возникает много сложностей, потому что нередко лечению подвергаются больные с единственным глазом, способным видеть. Трудности облучения глаза связаны с большой лучевой нагрузкой, повреждением глаза, развитием блефарита, катаракты,

вторичной глаукомы, гиперемии дна (включая сосок) с кровоизлиянием и частичной отслойкой сетчатки и значительной потерей зрения. Иногда возникают изъязвления роговицы.

Цель

– изучить роль электронной терапии в лечении опухолей глаз и орбиты.

Материал и методы

Исследования проведены у 17 больных с морфологически верифицированными опухолями глаза и орбиты (плоскоклеточный рак – у 8 пациентов, ретинобластома – у 5, аденокарцинома – у 2, эозинофильная гранулема – у 2 пациентов). Терапия быстрыми электронами с энергией 1% МЭв показала, что 80% изодозы электронного пучка зависит от размеров полей и достигают глубины 4–4,5 см, а 10% падают на глубину не более 7 см. Эти глубины считаются наиболее выгодными при лучевом лечении глаз. Количество и размеры полей выбирались индивидуально в зависимости от локализации и распространенности процесса. Облучение проводилось по 2 Гр ежедневно или по 4 Гр через день при мощности дозы 35–40 рад/мин. Общая суммарная доза доводилась в зависимости от характера опухоли.

Результаты

Изучение отдаленных результатов после проведенной электронной терапии показало, что из 17 больных через 3 года живы 12, умерло 4, нет сведений об одном больном. Следовательно, летальность среди больных отмечалась у больных с Ш и 1У стадиями. При комбинированном методе лечения выявляется зависимость процента излечения от степени распространенности опухоли к моменту лечения. Если лечение проводилось в более ранние сроки, процент излечения был высоким. При лечении в период, когда опухоль вышла за пределы глазного яблока, процент излечения был меньше. Удовлетворительные непосредственные и ближайшие результаты позволяют нам рекомендовать применение быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда имеет место прорастание опухоли за пределы глаза.

Комбинированное лечение с хирургическим вмешательством сделано 35 больным в виде пред- и послеоперационного облучения. Лечение в основном подвергались больные с запущенным процессом.

Лечение опухолей глаза до сих пор остается трудной и далеко не решенной задачей клинической офтальмологии. Это объясняется сложными анатомическими особенностями органа, разнообразием гистологической структуры опухолей и различной степенью их злокачественности. Наиболее распространенным методом лечения является хирургическое вмешательство, однако оно во многих случаях не спасает больных от генерализации опухолевого процесса. Химиотерапия в основном используется в плане комплексного лечения.

Многие авторы признают наиболее рациональным методом лечения лучевую терапию или ее сочетание с операцией. Благодаря лучевой терапии во многих случаях удавалось перевести процесс из неоперабельного состояния в операбельное или уничтожить остаточные опухолевые элементы после проведенной операции.

Облучение опухолей у детей в возрасте до 3–4 лет представляло большие трудности, поэтому оно проводилось во время физиологического сна. Когда это не удавалось, пользовались наркозом.

Объем хирургического вмешательства зависит от характера и распространенности процесса – экзеклеации или экзентерации глаза. При двустороннем поражении удаляется тот

глаз, в котором процесс развит сильнее, а второй глаз подвергается облучению.

Результаты. Изучение отдаленных результатов после проведенной электронной терапии показало, что из 17 больных через 3 года живы 12, умерло 4, нет сведений об одном больном. Следовательно, летальность среди больных отмечалась у больных с Ш и 1У стадиями. При комбинированном методе лечения выявляется зависимость процента излечения от степени распространенности опухоли к моменту лечения. Если лечение проводилось в более ранние сроки, процент излечения был высоким. При лечении в период, когда опухоль вышла за пределы глазного яблока, процент излечения был меньше. Удовлетворительные непосредственные и ближайшие результаты позволяют нам рекомендовать применение быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда имеет место прорастание опухоли за пределы глаза. Распределение дозы электронного пучка при облучении ретробульбарной опухоли показано на рисунке 1.

Следует отметить, что для обеспечения абластичности и радикальности хирургического вмешательства мы считали целесообразным проводить предоперационное облучение. Девитализация опухолевых клеток после облучения дает возможность обеспечить выполнение онкологического принципа радикального лечения.

Техника облучения опухоли глаз осложняется тем, что необходимо сохранять зрение. Кроме того, нужно полностью избежать облучения головного мозга. В связи с этим выбор условий облучения должен быть индивидуальным.

У больных, подвергавшихся электронной терапии, локализация процесса была следующей: 1) опухоль внутри глаза, 2) опухоль в ретробульбарном пространстве. 3) анофтальм после удаления внутриглазной опухоли, 4) состояние после экзентерации глазницы. В каждом конкретном случае индивидуально планировались условия облучения. Облучение проводилось с одного переднего орбитального поля или с двух взаимоперпендикулярных полей (орбитального и височного).

Успех лучевой терапии орбиты, помимо характера и распространенности процесса, в значительной мере определяется правильным выбором метода и условий облучения, позволяющих подвести к опухоли необходимую дозу за курс лечения при минимальном облучении окружающих тканей.

Учитывая изодозное распределение электронного пучка, мы применяли электроны 66 больным с опухолями глаза и орбиты. Большинство больных, находились в клинике Казахского НИИ глазных болезней. Облучение проводилось после совместного осмотра окулиста и онкорадиолога.

Электронная терапия имеет преимущества перед рентгеновским и гамма-излучением. Они заключаются в резком спаде дозы за очагом поражения, гомогенном распределении ее до определенной глубины проникновения электронов зависит от энергии генерирования. Это побудило нас детально изучить особенности применения быстрых электронов при лечении опухолей глаз и орбиты. Прежде всего необходимо было выяснить дозное распределение энергии излучения при электронной терапии патологических очагов, расположенных в глазном яблоке и орбите и разработать методику их лечения. Облучение быстрыми электронами мы проводили с помощью специальных тубусов.

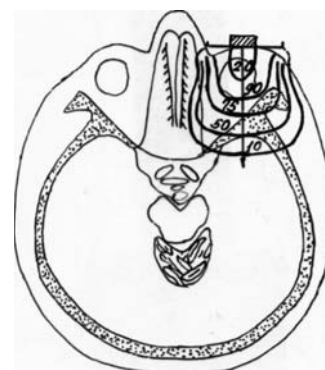


Рисунок 1. Дозное распределение при облучении ретробульбарной опухоли электронным пучком с применением свинцового поглотителя